

Sífilis y neurosífilis

Etapas clínicas e interpretación serológica · Cuándo puncionar · Penicilina siempre, y desensibilizar en el embarazo

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: VDRL: *Venereal Disease Research Laboratory* · RPR: *rapid plasma reagin* · FTA-ABS: *fluorescent treponemal antibody absorption* · MHA-TP / TPHA / TPPA: pruebas treponémicas de hemaglutinación · EIA/QMIA: inmunoensayos treponémicos automatizados · LCR: líquido cefalorraquídeo · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · HSH: hombres que tienen sexo con hombres · JH: reacción de Jarisch-Herxheimer · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en las *Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines* de los CDC (2021), las guías europeas (IUSTI), las recomendaciones de la OMS, y la **Norma de manejo y tratamiento de la sífilis del MINSAL**. **La sífilis es una enfermedad de notificación obligatoria en Chile, y la sífilis gestacional y congénita tienen normas específicas: verificar la versión vigente del MINSAL y el flujo de confirmación con el ISP.**

Índice

1. Por qué sigue importando
2. El agente y la transmisión
3. Etapas clínicas
4. Sífilis primaria
5. Sífilis secundaria
6. Sífilis latente
7. Sífilis terciaria
8. Neurosífilis, sífilis ocular y ótica
9. Pruebas serológicas: cómo funcionan
10. Algoritmos diagnósticos
11. Interpretación de los patrones serológicos
12. Cuándo hacer punción lumbar
13. Interpretación del LCR
14. Tratamiento por etapa
15. Alergia a penicilina y desensibilización
16. Reacción de Jarisch-Herxheimer
17. Seguimiento serológico y fracaso terapéutico
18. Sífilis y VIH
19. Sífilis en el embarazo y sífilis congénita
20. Notificación, parejas y prevención
21. Errores frecuentes
22. Perlas de alto rendimiento
23. Bibliografía esencial

1. Por qué sigue importando

La sífilis ha experimentado un **aumento sostenido** en Chile y en el mundo en las últimas dos décadas, con incremento particular en HSH, en personas con VIH y —lo más preocupante— en **embarazadas**, con el consiguiente repunte de la **sífilis congénita**, que es enteramente prevenible.

Es, además, **la gran simuladora**: puede imitar prácticamente cualquier enfermedad dermatológica, neurológica u oftalmológica, y por eso se pierde con facilidad si no se piensa en ella.

2. El agente y la transmisión

- ***Treponema pallidum* subespecie *pallidum***: espiroqueta **no cultivable** en medios habituales.
- **Transmisión: sexual** (contacto con lesiones infectantes: chancro, lesiones mucocutáneas del secundario), **vertical** (transplacentaria, en cualquier trimestre y en cualquier etapa de la sífilis materna), y excepcionalmente por transfusión o inoculación directa.
- **Contagiosidad**: máxima en la **sífilis primaria y secundaria**, y en la **latente precoz**. La sífilis latente tardía y la terciaria **no son contagiosas por vía sexual**, pero la transmisión vertical puede ocurrir años después de la infección materna.

3. Etapas clínicas

```
Exposición
| 10-90 días (media 21)
SÍFILIS PRIMARIA – chancro (cura sola en 3-6 semanas)
| 4-10 semanas
SÍFILIS SECUNDARIA – diseminación hematógena (cura sola en semanas a meses)
|
SÍFILIS LATENTE – asintomática, sólo serología positiva
+-- LATENTE PRECOZ (< 1 año desde la infección) – contagiosa, puede recaer al secundario
+-- LATENTE TARDÍA (> 1 año o de duración desconocida)
| años a décadas (en ~1/3 de los no tratados)
SÍFILIS TERCIARIA – gomas, sífilis cardiovascular, neurosífilis tardía

NEUROSÍFILIS puede ocurrir en CUALQUIER etapa, incluso precozmente
```

El punto que más se confunde: la **neurosífilis no es sinónimo de sífilis terciaria**. La invasión del sistema nervioso central ocurre **precozmente**, en las primeras semanas o meses, y las formas **meníngea, meningovascular, ocular y ótica** son manifestaciones tempranas.

4. Sífilis primaria

- **Chancro**: úlcera **única** (aunque pueden ser múltiples, sobre todo en personas con VIH), **indolora**, de **bordes indurados, fondo limpio y base dura**, en el sitio de inoculación.
- **Adenopatías regionales bilaterales, indoloras y no supurativas**.
- **Localización**: genital, pero también **anal, rectal, oral, faríngea o labial** — las extragenitales pasan desapercibidas con frecuencia, especialmente en HSH y en mujeres.
- **Cura espontáneamente en 3-6 semanas aunque no se trate**, lo que explica la progresión silenciosa.
- **Diagnóstico**: serología; **campo oscuro o inmunofluorescencia directa** de la lesión donde esté disponible (no aplicable a lesiones orales por la flora treponémica comensal); PCR en algunos centros.
- **La serología puede ser todavía negativa en el chancro muy precoz**: si la sospecha es alta, se **trata y se repite la serología en 2-4 semanas**.

5. Sífilis secundaria

Corresponde a la **diseminación hematógena** y aparece 4-10 semanas después del chancro (que puede aún estar presente en un 15-30 % de los casos).

Manifestación	Detalle
Exantema maculopapular	No pruriginoso , generalizado, que compromete palmas y plantas — el hallazgo más característico
Condilomas planos	Lesiones húmedas, elevadas, en zonas intertriginosas y perianales. Altamente infectantes
Parches mucosos	Lesiones blanquecinas en boca y genitales
Alopecia "en parches apolillados"	Característica
Adenopatías generalizadas	Indoloras, incluidas epitrocleares (muy sugerentes)

Manifestación	Detalle
Síntomas constitucionales	Fiebre, malestar, cefalea, mialgias, faringitis
Compromiso de órganos	Hepatitis sifilítica (fosfatasa alcalina desproporcionadamente elevada), glomerulonefritis, uveítis, hipoacusia , artritis, periostitis, meningitis

En esta etapa la serología es prácticamente siempre positiva y con títulos altos.

Fenómeno de prozona: en la sífilis secundaria con títulos muy altos, el exceso de anticuerpos puede impedir la formación del retículo de flocculación y producir un **VDRL o RPR falsamente negativo**. Se resuelve diluyendo la muestra; **si el cuadro clínico es muy sugerente y la prueba no treponémica es negativa, hay que pedir expresamente al laboratorio que descarte prozona.**

6. Sífilis latente

- **Definición:** serología positiva **sin manifestaciones clínicas**.
- **Latente precoz:** infección adquirida en **el último año**, documentada por: seroconversión o aumento de cuatro veces del título en el último año, síntomas inequívocos de sífilis primaria o secundaria en el último año, o **pareja sexual con sífilis primaria, secundaria o latente precoz en el último año**.
- **Latente tardía o de duración desconocida:** todo el resto. **En la práctica, la mayoría de los pacientes sin documentación previa se clasifican como "latente de duración desconocida" y se tratan como tardía.**
- **La distinción importa** porque determina la duración del tratamiento (una dosis frente a tres dosis de penicilina benzatina) y el manejo de contactos.

7. Sífilis terciaria

Ocurre en aproximadamente **un tercio de los pacientes no tratados**, años a décadas después.

Forma	Manifestaciones
Sífilis gomatosa	Lesiones granulomatosas destructivas en piel, hueso, hígado y otros órganos
Sífilis cardiovascular	Aortitis de la aorta ascendente, con aneurisma, insuficiencia aórtica y estenosis de los ostium coronarios. Clásicamente 10-30 años después
Neurosífilis tardía	Tabes dorsal y paresia general (sección 8)

8. Neurosífilis, sífilis ocular y ótica

La invasión del SNC ocurre **precozmente**, y sus manifestaciones se distribuyen en el tiempo:

Forma	Momento	Manifestaciones
Meningitis sifilítica	Precoz (primeros meses-2 años)	Cefalea, rigidez de nuca, compromiso de pares craneales (VII, VIII), hidrocefalia
Meningovascular	Precoz-intermedia (5-10 años)	Accidente cerebrovascular en un paciente joven , por arteritis. Debe estar en el diferencial del ictus del adulto joven
Sífilis ocular	Cualquier etapa	Uveítis (anterior, posterior, panuveítis), retinitis, neuritis óptica. Pérdida visual
Sífilis ótica	Cualquier etapa	Hipoacusia neurosensorial , tinnitus, vértigo
Paresia general	Tardía (10-25 años)	Demencia progresiva, cambios de personalidad, psicosis, temblor
Tabes dorsal	Tardía (15-30 años)	Ataxia sensitiva, dolores lancinantes , pupila de Argyll Robertson (acomoda pero no reacciona a la luz), incontinencia, artropatía de Charcot, arreflexia

Regla operativa fundamental La sífilis ocular y la sífilis ótica se tratan **SIEMPRE** con el esquema de neurosífilis (penicilina G endovenosa), **independientemente del resultado del líquido cefalorraquídeo y de la etapa clínica**. Son urgencias: el retraso se traduce en pérdida visual o auditiva permanente.

Toda uveítis, neuritis óptica o hipoacusia neurosensorial de causa no aclarada obliga a solicitar serología de sífilis.

9. Pruebas serológicas: cómo funcionan

Tipo	Ejemplos	Qué detectan	Características
No treponémicas	VDRL, RPR	Anticuerpos contra cardiolipina (antígeno lipídico liberado por el daño tisular)	Cuantitativas (se informan en títulos). Se negativizan o descienden con el tratamiento : son las que se usan para seguimiento . Menos específicas: dan falsos positivos
Treponémicas	FTA-ABS, MHA-TP, TPHA, TPPA, EIA/QMIA automatizados	Anticuerpos contra antígenos específicos de <i>T. pallidum</i>	Cualitativas. Permanecen positivas de por vida en la mayoría de los pacientes, tratados o no: NO sirven para seguimiento ni para distinguir infección activa de pasada

Causas de falsos positivos de las pruebas no treponémicas (habitualmente con **títulos bajos**, $\leq 1:8$): embarazo, edad avanzada, infecciones agudas virales y bacterianas, vacunación reciente, **enfermedades autoinmunes** (**lupus**, **síndrome antifosfolípidos**), hepatopatía crónica, uso de drogas intravenosas, neoplasias, tuberculosis, malaria, endocarditis.

Causas de falsos negativos: sífilis primaria muy precoz, **fenómeno de prozona** en el secundario, y sífilis latente tardía (donde el VDRL puede negativizarse espontáneamente en un 25 % de los pacientes no tratados).

10. Algoritmos diagnósticos

Algoritmo tradicional:

```

Prueba NO treponémica (VDRL/RPR)  -> si es POSITIVA  -> Prueba TREPONÉMICA confirmatoria
                                   -> si es NEGATIVA  -> Sin sífilis
                                   (salvo sospecha de primaria precoz o de prozona:
                                   repetir en 2-4 semanas o pedir dilución)

```

Algoritmo reverso (cada vez más usado, porque los inmunoensayos treponémicos automatizados son baratos y de alto rendimiento):

```

Prueba TREPONÉMICA automatizada (EIA/QMIA)
|
+-----+-----+
NEGATIVA  POSITIVA
|          |
Sin sífilis  Prueba NO treponémica (RPR/VDRL) cuantitativa
|
+-----+-----+
POSITIVA    NEGATIVA
|           |
Sífilis (activa o tratada: evaluar con historia)  SEGUNDA prueba treponémica DISTINTA
|
+-----+-----+
POSITIVA    NEGATIVA
|           |
Sífilis pasada o latente tardía; evaluar clínica e historia de tratamiento  Probable falso positivo del tamizaje

```

En Chile, el flujo diagnóstico y la confirmación han estado normados con participación del **ISP** como laboratorio de referencia. **Verificar el algoritmo vigente del MINSAL**, que ha sido actualizado con la incorporación de las pruebas treponémicas automatizadas.

11. Interpretación de los patrones serológicos

No treponémica	Treponémica	Interpretación
Positiva	Positiva	Sífilis : activa no tratada, o tratada con títulos aún no negativizados. La historia clínica y de tratamiento decide

No treponémica	Treponémica	Interpretación
Negativa	Positiva	Sífilis tratada previamente (lo más frecuente), sífilis latente tardía , sífilis primaria muy precoz, o falso positivo de la prueba treponémica
Positiva	Negativa	Falso positivo de la prueba no treponémica (títulos habitualmente bajos), o sífilis primaria muy precoz
Negativa	Negativa	Sin sífilis, o infección muy reciente (período de ventana)

Regla de oro para el seguimiento: sólo tienen significado los cambios de **al menos cuatro veces** el título (dos diluciones: por ejemplo, de 1:32 a 1:8, o de 1:8 a 1:32), y **las comparaciones deben hacerse con la misma prueba y, preferentemente, en el mismo laboratorio** — los títulos de VDRL y RPR no son intercambiables.

12. Cuándo hacer punción lumbar

Indicaciones de punción lumbar en sífilis: - **Síntomas o signos neurológicos, oftalmológicos u óticos** de cualquier tipo. - **Evidencia de sífilis terciaria activa** (sífilis cardiovascular, gomas). - **Fracaso terapéutico:** falta de descenso adecuado de los títulos tras un tratamiento correcto, o aumento de cuatro veces del título.

NO se requiere punción lumbar de rutina en la sífilis primaria, secundaria o latente sin síntomas neurológicos, **ni siquiera en personas con VIH**, según las guías actuales. La práctica antigua de puncionar a todo paciente con VIH y sífilis latente ha sido abandonada.

Excepción práctica y no negociable: en la **sífilis ocular u ótica**, se trata con el esquema de neurosífilis **independientemente de si se realiza la punción o de su resultado**. La punción puede hacerse, pero **no condiciona la decisión terapéutica**.

13. Interpretación del LCR

Hallazgo	Interpretación
VDRL en LCR positivo	Altamente específico (confirma neurosífilis), pero poco sensible (negativo en 30-70 % de las neurosífilis)
FTA-ABS en LCR	Muy sensible pero poco específico (contaminación por anticuerpos séricos). Su principal valor es el negativo , que hace muy improbable la neurosífilis
Pleocitosis > 5-10 leucocitos/μL (linfocitaria)	Apoya el diagnóstico. En personas con VIH, el umbral suele elevarse a > 20 células/μL , porque el VIH por sí solo produce pleocitosis
Proteínas elevadas (> 45-50 mg/dL)	Apoya el diagnóstico

El diagnóstico de neurosífilis es una combinación de clínica, serología sérica reactiva y hallazgos del LCR; **ningún parámetro aislado lo confirma ni lo descarta**.

14. Tratamiento por etapa

La penicilina G es el único tratamiento de eficacia plenamente establecida en todas las etapas.

Etapas	Tratamiento
Primaria, secundaria y latente precoz	Penicilina G benzatina 2.400.000 UI IM en dosis ÚNICA
Latente tardía o de duración desconocida, y terciaria (sin neurosífilis)	Penicilina G benzatina 2.400.000 UI IM semanal por 3 semanas (total 7.200.000 UI). Si se pierde una dosis y transcurren más de 10-14 días, reiniciar la serie
Neurosífilis, sífilis ocular y sífilis ótica	Penicilina G sódica 18-24 millones UI/día IV , administrada como 3-4 millones UI cada 4 h o en infusión continua, por 10-14 días . Alternativa: penicilina G procaína 2,4 millones UI IM/día más probenecid 500 mg cada 6 h por 10-14 días. Muchos expertos agregan al final penicilina benzatina 2,4 millones UI semanal por 1-3 semanas
Alternativas en alergia (NO embarazo, NO neurosífilis)	Doxiciclina 100 mg VO cada 12 h por 14 días (primaria, secundaria, latente precoz) o por 28 días (latente tardía). Alternativa: ceftriaxona (esquemas variables, con menor evidencia)
Embarazo	Penicilina G benzatina según la etapa. La embarazada alérgica DEBE ser desensibilizada — no existe alternativa aceptada

Un punto operativo importante: en la sífilis primaria, secundaria y latente precoz **una sola dosis basta**; el esquema de tres dosis para estas etapas, aunque frecuente en la práctica, **no aporta beneficio adicional demostrado**.

15. Alergia a penicilina y desensibilización

- **La penicilina es insustituible** en el embarazo, en la neurosífilis y en la sífilis congénita.
- **Ante un antecedente de alergia**, lo primero es **evaluar la etiqueta**: más del 90 % de los "alérgicos a penicilina" no lo son (ver el documento de Alergia a penicilina). Las pruebas cutáneas y la provocación permiten desetiquetar a la mayoría.
- **Si la alergia IgE está confirmada y la penicilina es imprescindible, se desensibiliza**: administración de dosis crecientes en un área monitorizada, con adrenalina disponible. La tolerancia es transitoria y se pierde a las 48 horas de suspender el fármaco.
- **La desensibilización está contraindicada** si la reacción previa fue **DRESS, Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica o una citopenia inmune**: en esos casos hay que consultar con infectología e inmunología para definir una alternativa.
- **La doxiciclina NO es una alternativa aceptable en el embarazo** (está contraindicada y su eficacia para prevenir la sífilis congénita no está establecida).

16. Reacción de Jarisch-Herxheimer

- **Qué es**: respuesta inflamatoria sistémica por la **liberación masiva de lipoproteínas y citoquinas al lisarse las espiroquetas** tras la primera dosis de antibiótico.
- **Clínica**: fiebre, calofríos, cefalea, mialgias, taquicardia, hipotensión leve, exacerbación transitoria de las lesiones cutáneas. Comienza en **2-8 horas** y **se resuelve en 24 horas**.
- **Frecuencia**: hasta el **50-75 % de los pacientes con sífilis secundaria**; menos frecuente en las etapas tardías.
- **Manejo**: antipiréticos e hidratación. **NO es alergia y NO se suspende el tratamiento**.
- **Advertir siempre al paciente** antes de administrar la primera dosis, para evitar que interprete la reacción como alergia y abandone el tratamiento.
- **En la embarazada puede desencadenar contracciones, sufrimiento fetal o parto prematuro**: se recomienda administrar el tratamiento con monitorización obstétrica en la sífilis del tercer trimestre, y advertir a la paciente que consulte ante contracciones o disminución de movimientos fetales.

17. Seguimiento serológico y fracaso terapéutico

Seguimiento con prueba NO treponémica cuantitativa (siempre la misma prueba y, de ser posible, el mismo laboratorio):

Etapas	Controles
Primaria y secundaria	6 y 12 meses (algunos protocolos añaden 3 meses)
Latente	6, 12 y 24 meses
Neurosífilis	Serología sérica cada 6 meses; punción lumbar de control cada 6 meses hasta la normalización de la celularidad (si estaba alterada)
Personas con VIH	Controles más frecuentes: 3, 6, 9, 12 y 24 meses
Embarazo	Mensual hasta el parto, según norma

Respuesta adecuada: descenso de **al menos cuatro veces el título (dos diluciones)** a los 6-12 meses en la sífilis precoz, y a los 12-24 meses en la latente.

Fracaso terapéutico o reinfección — se define por:

- **Persistencia o recurrencia de síntomas**, o - **Aumento de cuatro veces el título** respecto del basal o del nadir, o - **Falta de descenso de cuatro veces el título** en el plazo esperado.

Conducta: evaluar **reinfección** (lo más frecuente, sobre todo si hay exposición sexual continuada), **estudiar VIH**, **realizar punción lumbar** para descartar neurosífilis, y **retratar** — habitualmente con **penicilina benzatina 2,4 millones UI semanal por 3 semanas**, o con el esquema de neurosífilis si esta se confirma.

"Serofast": entre el 15 % y el 20 % de los pacientes correctamente tratados mantiene títulos bajos persistentes (habitualmente $\leq 1:8$) sin evidencia de infección activa. **No requiere retratamiento indefinido** si el descenso inicial fue adecuado, no hay síntomas y no hay reexposición; requiere seguimiento.

18. Sífilis y VIH

- **La coinfección es muy frecuente:** toda persona con sífilis debe ser estudiada para VIH, y toda persona con VIH debe tener tamizaje periódico de sífilis.
- **La sífilis facilita la transmisión y la adquisición del VIH** por la disrupción mucosa y el reclutamiento de células diana.
- **Particularidades en personas con VIH:**
 - Mayor frecuencia de **chancros múltiples**, de solapamiento de etapas, y de presentaciones atípicas o más agresivas (**lues maligna**).
 - Mayor riesgo de **neurosífilis precoz**, sobre todo con **CD4 < 350** y **VDRL sérico >= 1:32**.
 - Serología con títulos más altos y, ocasionalmente, respuestas atípicas o retardadas.
 - **Seguimiento serológico más frecuente.**
- **El tratamiento es el mismo por etapa; no se recomienda intensificar el esquema de rutina.**
- **La punción lumbar de rutina en la sífilis latente sin síntomas neurológicos no está indicada** en personas con VIH, según las guías actuales.

19. Sífilis en el embarazo y sífilis congénita

Es el escenario donde el error tiene consecuencias más graves y más evitables.

- **La transmisión vertical ocurre en cualquier trimestre y en cualquier etapa de la sífilis materna**, con mayor riesgo en la sífilis precoz (hasta 60-100 % en la primaria y secundaria no tratadas).
- **Consecuencias:** aborto, muerte fetal, hidrops, prematuridad, muerte neonatal, y sífilis congénita precoz (hepatoesplenomegalia, exantema, rinorrea sanguinolenta, osteocondritis, pseudoparálisis de Parrot) y tardía (dientes de Hutchinson, queratitis intersticial, sordera —la tríada de Hutchinson—, nariz en silla de montar, tibias en sable, articulaciones de Clutton).
- **Tamizaje:** el MINSAL norma el tamizaje serológico en el embarazo, con controles en distintos momentos de la gestación y en el parto. **Verificar el esquema vigente.**
- **Tratamiento: penicilina G benzatina según la etapa.** Muchos protocolos recomiendan, en la sífilis precoz del embarazo, **una segunda dosis a la semana** para asegurar el tratamiento fetal.
- **La embarazada alérgica se DESENSIBILIZA:** no hay alternativa aceptada.
- **El tratamiento se considera adecuado para prevenir la sífilis congénita sólo si se administró penicilina y se completó al menos 30 días antes del parto.**
- **La sífilis gestacional y la sífilis congénita son de notificación obligatoria inmediata**, y activan el estudio y tratamiento del recién nacido y de la pareja.

20. Notificación, parejas y prevención

- **Notificación obligatoria** de la sífilis según el decreto vigente del MINSAL, con **confidencialidad**.
- **Estudio y tratamiento de parejas sexuales:**
 - **Sífilis primaria:** parejas de los **90 días** previos.
 - **Sífilis secundaria:** parejas de los **6 meses** previos.
 - **Sífilis latente precoz:** parejas del **último año**.
 - **Toda pareja expuesta en esos plazos se trata presuntivamente**, aunque su serología sea negativa.
 - En la **sífilis latente tardía**, se estudia a las parejas actuales y a los hijos.
- **Prevención:** preservativo (que reduce pero no elimina el riesgo, porque las lesiones pueden estar fuera del área cubierta), tamizaje periódico en poblaciones de riesgo, **PrEP** para VIH con su tamizaje asociado de ITS, y consejería.
- **La doxiciclina como profilaxis postexposición para ITS bacterianas** ha mostrado en ensayos clínicos reducción de la incidencia de sífilis y clamidia en poblaciones seleccionadas de alto riesgo; **su implementación depende de las recomendaciones nacionales vigentes** y debe consensuarse con el programa correspondiente.

21. Errores frecuentes

- Usar una prueba treponémica para seguimiento: permanece positiva de por vida. - Comparar títulos de VDRL con títulos de RPR, o de laboratorios distintos. - Descartar sífilis secundaria por un VDRL negativo sin considerar el fenómeno de prozona. - Descartar sífilis primaria por serología negativa en un chancro muy precoz. - No tratar la sífilis ocular u ótica con esquema de neurosífilis, o supeditar al resultado del LCR. - Puncionar de rutina a toda persona con VIH y sífilis latente asintomática. - Dar doxiciclina a una embarazada alérgica en lugar de desensibilizar. - Interpretar la reacción de Jarisch-Herxheimer como alergia y suspender el tratamiento. - No advertir al paciente sobre la reacción de Jarisch-Herxheimer antes de la primera dosis. - Reiniciar tratamiento indefinidamente en un paciente "serofast" que descendió adecuadamente. - No estudiar ni tratar a las parejas en los plazos correspondientes. - No solicitar serología de sífilis ante una uveítis, una neuritis óptica, una hipoacusia neurosensorial o un ictus en un paciente joven. - No notificar.

22. Perlas de alto rendimiento

- No treponémicas (VDRL/RPR) para seguimiento; treponémicas para confirmar y quedan positivas de por vida.
- Sólo importan los cambios de cuatro veces el título (dos diluciones), con la misma prueba y el mismo laboratorio.
- Prozona: secundario con títulos altísimos puede dar un VDRL falsamente negativo — pedir dilución.
- Chancro: único, indoloro, indurado, de fondo limpio, y cura solo.
- Secundario: exantema que compromete palmas y plantas, condilomas planos, alopecia en parches.
- La neurosífilis puede ser precoz: no es sinónimo de sífilis terciaria.
- Sífilis ocular u ótica = esquema de neurosífilis, siempre, sin importar el LCR.
- VDRL en LCR: muy específico, poco sensible.
- Primaria, secundaria y latente precoz: UNA dosis de penicilina benzatina. Latente tardía: TRES dosis semanales. Neurosífilis: penicilina G sódica endovenosa 10-14 días.
- La embarazada alérgica se desensibiliza; la doxiciclina no es alternativa.
- Jarisch-Herxheimer no es alergia: se avisa, se trata con antipiréticos y no se suspende el antibiótico.
- Toda persona con sífilis debe estudiarse para VIH, y viceversa.
- Parejas: 90 días en primaria, 6 meses en secundaria, 1 año en latente precoz — se tratan presuntivamente.
- La sífilis gestacional y congénita son de notificación inmediata, y el tratamiento debe completarse al menos 30 días antes del parto.

23. Bibliografía esencial

- Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1-187.
- Janier M, Unemo M, Dupin N, et al. 2020 European guideline on the management of syphilis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2021;35:574-88.
- World Health Organization. *WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis)*. 2016.
- Ghanem KG, Ram S, Rice PA. The modern epidemic of syphilis. *N Engl J Med*. 2020;382:845-54.
- Marra CM, Maxwell CL, Smith SL, et al. Cerebrospinal fluid abnormalities in patients with syphilis: association with clinical and laboratory features. *J Infect Dis*. 2004;189:369-76.
- Luetkemeyer AF, Donnell D, Dombrowski JC, et al. Postexposure doxycycline to prevent bacterial sexually transmitted infections. *N Engl J Med*. 2023;388:1296-306.
- Ministerio de Salud de Chile. Norma de manejo y tratamiento de la sífilis; Norma de prevención de la transmisión vertical de la sífilis. Verificar las versiones vigentes en www.minsal.cl.